EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 85783
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-06-01 11:01:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LUIS FLORIDOR CONTRERAS SEPULVEDA			**RUN**	: 4.891.390-3
F.Nac	: 02-09-1942	**Edad**	: 81 AÑOS, 8 MESES	**Género**	: Masculino
Dirección	: LA PRIMAVERA SAN CARLOS.			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-05-29	**Fecha Egreso**	: 2024-06-01 11:01:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: DOMICILIO	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1-ITU X Klebsiella BLEE/ E. Faecium
2-Artritis septica de rodilla reciente
3-HTA
4-Reemplazo valvular aortico
5-Hipovitaminosis D

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Hombre de 81 años.
- Reemplazo valvular aórtico biológico en 2009, actualmente con estenosis severa de la prótesis.
- HTA etapa 2.
- Gonartrosis, usa bastón.
- Ex-tabaquista >20 años.

Paciente de 81 años con estenosis aórtica severa de prótesis biológica implantada en 2009, en estudio para eventual TAVI.
Durante abril 2024 se hospitaliza por artritis séptica de rodilla izquierda, con cultivo intraoperatorio (+) a Streptococcus mitis/oralis. Recibe inicialmente 4 días de Cloxacilina EV.
Evoluciona con parámetros inflamatorios persistentemente elevados pese a mejoría de rodilla. Se sospecha endocarditis como foco secundario, pero ecocardiograma transtorácico del 10/05 no muestra vegetaciones. Además, presenta ITU por Klebsiella BLEE multi resistente, que se plantea como posible foco primario de la artritis. Se ajusta antibióticos a Imipenem/Cilastatina.
El 27/05 se constata pancitopenia (Hb 10.6, GB 2230, plaquetas 110.000), sospechada como reacción adversa al Imipenem (día 18 de 42). Exámenes previos del 21/05 eran normales.
Es derivado desde hospital comunitario para manejo de pancitopenia y continuar tratamiento antibiótico.
Al examen físico destaca soplo sistólico aórtico, sin otros hallazgos significativos. Paciente permanece hospitalizado manteniendose hemodinamicamente estable, afebril, Ajustan ATB a Gentamicina 160mg ev cada 24 horas. Para el dia de hoy paciente en estables condiciones, asintomatico se valoran laboratorios de control donde no se objetiva Pancitopenia solo persiste anemia probablemente secundaria a enfermedades cronicas, sin criterios para anemia ferropenica ni megaloblastica . Funcionalismo renal conservado. se objetiva Hipovitaminosis D por lo que indico tratamiento, asi mismo en base a Urocultivo del 20/5/2024 que tambien reporto

Enterococcus Faecium indico linezolid 600mg cada 12 horas por 10 dias. Paciente en condicion clinica para HODOM.

INDICACIONES AL ALTA

1. 1-Omeprazol 20mg via oral cada 12 horas
2. 2-Gentamicina 160mg ev dia dia 3/7
3. 3-Linezolid 600mg via oral cada 12 horas
4. 4-bisoprolol 2.5mg via oral dia
5. 5-tamsulosina 0.4mg via oral dia
6. 6-colecalciferol 1sobre semanal x 8 semanas
7. 7-Losartan potasico 25mg via oral cada 12 horas
8. 8-seguimiento en HODOM
9. 9-Al terminar tto ATB control de urocultivo

EXÁMENES Y RESULTADOS

ver historia

jesus luis antonio perez lozada
MEDICO TRATANTE
26918952-5

JEFE SERVICIO